

❖ 환자 교육

- ① 안심시키는 것이 가장 중요
- ② 임신, 성병, HIV, HBV 등은 초기 검사 결과에 상관없이 예방적 치료 시행
- ③ 파상풍 치료는 deep tissue wound나 bite wound가 있는 경우에만 시행
- ④ 매독, B형 간염, HIV는 성 폭행 후 6주, 12주, 24주에 반복하여 혈청검사 시행
- ⑤ 그 외에도 신체적인 손상에 대해 치료

암기법 SP 이상해

설명 임신(Pregnancy), 성병(STD)예방, 에이즈, 파상풍, 해바라기 센터 안내

무조건 치료	임신	Levonorgestrel 0.75mg 2 tablets 즉시(24시간 내) or Mifepristone 10mg 한 알 or 35ug 복합경구피임약 4알 즉시, 12시간 후 반복 or Copper IUG 거치(7일까지)
	Gonorrhea	Ceftriaxone 125mg IM or Ciprofloxacin 500mg PO or Spectinomycin 2g IM
	Chlamydia	Azithromycin 1g PO or Doxycycline 100mg PO bid for 7일 Erythromycin 500mg PO qid for 7일
	트리코모나스, 세균성 질염	Metronidazole 2g PO
	HBV	vaccine 1mL IM 1, 6개월 반복 접종
	HIV	Zidovudine 300mg and Lamivudine 150mg PO bid, 28일
깊은 상처, 물린 상처 있는 경우만		파상풍 Td 0.5mL IM



keyword

가정 폭력 : 환자 주소에 따른 문진하다 비밀 보장 언급하며 폭력 사실 묻기
 성 폭력 : 비밀 보장 언급, 진료 과정 소개(면담, 사진, P/E 및 증거물 채취), 동의서
 육하원칙 : 누가, 언제, 어디서, 어떻게(성 폭력: 질/구강/항문/콘돔/사정 여부)
 기타 문진 : 정신과, (성 폭력) 임신, LMP
 (성 폭력) 신체 진찰 : 구강, 외상, 골반 내진, 질분비물 + 증거 + 도말, DRE
 환자 교육 : 폭력의 부당함 인식, 법적 보호, 보호 시설
 환자 교육(성 폭력) : 임신(72시간 내) / 성병(항생제) / 에이즈(가능성 낮음, 6개월)
 의사-환자 관계 : 공감, 취조/조급 ×

시험 관영 코멘트



스스로 선택에 자책하지 말라고 하는 것 중요!! 입원 권유를 2번 이상 해야 합니다. '치료 계획' 부분 참고하여 **멘트 미리 정해 놓는 것**이 필요합니다.

자살 증례는 엄숙하고 진지한 분위기에서 상담을 진행하는 것이 좋습니다. **비판적인 말을 하지 않는 것**이 좋으며, 환자가 자살을 시도할 정도로 **힘들었을 상황에 공감**하고, **정서적 지지**를 표하는 것이 좋습니다. 원칙적으로는 자살 시도로 내원한 환자는 입원 치료가 필요합니다. 하지만 **두 번 이상 입원을 권유**했음에도 입원 치료를 거절하는 환자라면 **보호자의 24시간 감시 및 보호**가 있는 상태에서 **낮 병동 입원 치료**와 같은 대체 방안을 제시할 수 있습니다.

대부분의 자살 케이스에서는 신체 진찰을 시행하지 않지만 그럼에도 시간이 부족한 경우가 많으므로 **시간 조절에 유의**하며 연습하세요. 환자의 말 속도가 느릴 수도 있고, 입을 열기 주저할 수도 있습니다. 마음이 조급할 수 있지만, **꼭 SP 속도에 맞춰서 천천히, 차분히 진료**를 진행하면 됩니다.

반드시 **공감과 비밀 보장**으로 **상담을 시작**하도록 유의하시기 바랍니다. 우울증의 경우 마음의 감기로 뇌 신경물질 이상으로 인한 것으로 약물로 치료 가능하다고 설명 시 환자-의사 관계에 큰 도움이 될 것입니다.

상담 플로우

STEP 1 병력 청취

환자/의사 관계 형성 (1)	지금부터 약 10분 정도 동안 000씨가 겪은 일에 대해서 면담을 하려하는데 괜찮으신가요? 제가 알기로는 자살 시도를 하여 내원하신 걸로 알고 있습니다. 괜찮으시다면 그 부분에 대해서 먼저 얘기해 봐도 될까요? 우선 말씀드리고 싶은 것은 이 상담 내용의 모든 것은 비밀이 보장되니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 조금 힘들더라도 대답해 주시면 감사드리겠습니다. 저는 진심으로 000씨가 정말 걱정이 되기에 전문가적인 입장에서 의학적으로 최대한 도움을 드리고 싶습니다. 면담 중 힘드시면 언제든지 부담없이 말씀해 주세요.
이번 자살 시도	(자살 시도를 해서 온 경우 이번 자살 시도에 대해 자세히 묻기) 언제 이런 일이 발생했나요?/어떻게 자살을 시도하셨나요? 특별한 계기가 있었나요?/어떻게 내원하시게 되었나요? (자의/타의/목적된 것)

자살 사고 및 행동 평가 자살 사고 및 행동 평가	계기(Trigger)	자살 생각을 하게 된 계기나 사건이 있을까요?
	Onset	언제부터 자살에 대한 생각을 하셨나요?
	자살 계획 (Plan)	자살을 하기 위한 계획이 있으셨나요?
	자살 시도 유무 (Attempt)	이전에도 자살 시도를 하신 적이 있나요? → (했다면) 그때는 어떤 식으로 시도하셨나요?
	사고 빈도(Idea)	자살에 대한 생각을 평소에 계속 하셨나요? 몇 차례 하셨나요?
암기법 TOP AI		
병전 성격	평소 성격은 어떠셨나요? 사건 이전 이후로 성격이 달라지셨나요?	
주변 관계	가족 관계	가족 관계는 어떠셨나요?
	교우 관계	친구 관계는 어떠신가요?/주변에 도움을 줄 만한 분이 있나요?
환자/의사 관계 형성 (2)	(OOO한 상황에 의해) 많이 힘드셨겠군요. 자살이라는 어려운 선택을 하실 정도로 많이 힘들었을 것 같습니다. 하지만 병원에 오신 건 정말 잘하셨습니다. 이렇게 오셨으니 도움이 될 수 있는 건 다 도와드리고자 합니다. 도와드리기에 앞서 박OO씨의 상태를 정확히 판단을 해야 최선의 도움을 드릴 수 있을 듯 합니다. 몇 가지 질문을 더 드려도 될까요? 힘드시다면 말씀하셔도 됩니다.	
우울 증상 평가	[MDD 우울 척도 평가(9)] 우울, 흥미 감소, 식욕 감소, 수면 변화, 피로감, 집중력/기억력 감소, 무가치함/죄책감/정신 운동 초조, 자살 1. 하루 종일 우울하신가요? 2. 삶에 대한 흥미가 없으신가요? 3. 잠은 잘 주무시나요? 4. 식사는 잘하고 계신가요? 5. 피곤하신가요? 6. 집중력이 떨어지거나 기억력이 떨어지셨나요? 7. 삶에 대한 죄책감을 느끼시나요? 8. 불안하고 초조하신가요?	
기타 정신과적 장애	환청/환시 : 헛것이나 평소에 들리지 않던 소리를 들은 적이 있나요? 조증 : 기분이 갑자기 확 좋아진 적은 없나요?	

신체 증상 평가	환자가 호소하는 증상 중심으로 → 복통/홍통/두통/골절 특히 교맥의 경우 두통, 호흡곤란, 목 이물감 등 확인	
과거력 평가	외	자살 시도로 인해 다치거나 수술/입원하신 적이 있나요?
	과	이전에 정신과적으로 진단받았거나 치료받은 적이 있으신가요? 따로 앓고 계신 질병이 있을까요?
	약	복용 중인 약물이 있나요?
	사	술, 담배, 직업, 운동, 커피
	가	가족 중 정신과적 질환 있으신 분 있나요? 가족 중 자살 시도를 하셨던 분 있나요?
요약 및 치료 계획	(OOO한 상황에 의해) 어려운 상황에서 면담에 응해주셔서 감사드립니다. 이러한 상황에 처하게 된 것은 절대 OOO씨의 잘못이 아니니 스스로의 선택에 대해 자책하지 않으셨으면 합니다. 지금까지의 문진을 종합해 보았을 때 현재 하루 종일 우울하시고 잠도 잘 못 주무시는 것을 보아 OOO씨께서는 우울증 소견이 있으신 듯 합니다. 또한 자살 위험도가 높은 정신과적 응급이라고 할 수 있습니다. 이런 경우 혼자 지내시면 더욱 우울해지고 안 좋은 생각만 들게 되는데, 입원을 하면 저희가 가까이에서 OOO님을 지켜보며 최선의 도움을 드릴 수 있을 것 같습니다. 입원 치료에 대해 어떻게 생각하시나요? 입원 치료라는 것에 대해 부담을 가질 수 있습니다만 몇 일 쉬신다 생각하시고 상담 치료나 약물 치료 병행하시면 우울감이나 자살에 대한 생각에 대해서 좋은 결과가 있으리라 봅니다. 마음을 추스리는 시간을 갖는 게 좋을 것 같은데 어떠신가요? (환자에 대한 지지 및 치료에 대한 언급 및 교육을 하며 마무리)	

STEP 2 신체 검진



- 대개 할 필요 없는 것으로 주어집니다.
- 하면 **손, 발, 허벅지, 다리 등 주로 베이는 부위** 시진

STEP 3 환자 교육

환자 상태	환자의 스트레스 상태/우울증 등 정신과적 상태
현실적 지지	우울증은 약으로 치료가 가능하고, 스트레스 해소에 도움을 줄 것 가족에게 현재 상황을 이야기하는 것이 어떤지 물어보기 → 가족에게 알리기 싫어하는 경우 비밀 보호를 보장 환자의 불편함과 우울함에 대한 공감
입원 치료 필요성	[입원 결정 요소] 이전 자살 시도력, 자살의 가족력, 지지적이지 못한 가족 관계, 정신과 질환력, 충동적 행동, 만성 질환 자살 시도를 한 경우에는 이후 자살의 위험성이 매우 높으므로 반드시 입원 치료를 받는 것이 필요함을 강조 자살 시도 계획이 없더라도 정신 질환(우울증, 정신병적 증상 등)이 의심될 경우 검사 및 경과 관찰을 위해 입원이 필요할 수 있음을 설명 입원을 하지 않고, 불면, 기분 변화 등에 대해 약을 처방하게 될 경우 보호자의 통제 하에 단기간 처방하며, 정신과 외래에 반드시 방문하도록 교육 [설명] 환자분께서 현재 자살에 대해서 생각하고 있으며, 이전에도 시도해 보신 적이 있으므로 환자분을 위해서 입원하셔서 안정을 취하는 것이 필요합니다.

[유의점]

- ① 자살에 대해서는 직접적으로 질문하도록 한다.
- ② 고통에 대한 공감은 적절히 표현해야 함

예 사람들은 누구나 때때로 죽고 싶어 한다. (×)

그런 상황이라면 저라도 자살하겠다. (×)
- ③ 자살 생각이 있는 환자는 자기 비난에 매우 민감하므로 태도에 주의함
- ④ 질문은 하나씩 하고 환자의 말과 생각의 속도에 맞춘다.
- ⑤ 엄숙하고 진지한 태도로 경청
- ⑥ 희망적이지만 현실적으로 가능한 메시지를 전달

예 치료를 잘 받으면 우울증에서 회복될 수 있습니다. (○)
- ⑦ 비현실적이고 무조건적인 희망은 도움이 되지 않음

예 다 잘 될 겁니다. 걱정하지 마세요. (×)
- ⑧ 급작스러운 스트레스로 인해 자살 위험을 보이는 경우는 환자를 보호 및 지지해야 함



keyword

비밀 보장, 공감으로 상담 시작

자살에 대한 구체적 문진 (사고/계획/시도)

정신과적 평가(주요 우울장애, 기타 정신병적 장애, 가족력)

환자 교육 : 입원 치료 강조(2회), 거부 시 재방문 강조, 가족 참여 의사 확인

의사-환자 관계 : 정서적 지지, 지나치지 않은 공감, 희망적이나 현실적



참고자료

자살의 위험 요인 이정남심수지	MDD에서 입원해야 하는 요인
① 이전 자살 시도 ② 정신 질환 : 우울증, 조현병 ③ 알코올 남용 ④ 심각한 신체 질환/통증, 치료 실패/재발 ⑤ 심리사회적 스트레스 ⑥ 지지 체계 미비(가족 관계)	① 자살/타해 위험 ② 심한 생장성 증상 ③ 정신 증상 ⇨ Hallucination, Delusion ④ 병식이 없거나, 치료 거부 ⑤ 지지 체계가 좋지 않을 때 (혼자 사는 경우, 가족과 떨어져 생활) ⑥ 신체 질환이 동반되어 있는 경우 ⑦ 명확한 진단을 요할 때

주요 우울장애 DSM-5 진단 기준

하루 삶이 자다가 정신차려서 살피려고 피자사자

- ① **하루** 종일 우울한 기분(소아, 청소년에서는 irritability도 가능)
- ② **삶**에 대한 흥미 감소
- ③ **불면, 과수면**
- ④ **정신운동**초조, 흥분 또는 지체
- ⑤ **체중** 증가 또는 감소(소아에서는 성장에 따른 체중 증가가 안 됨)
- ⑥ **피로감**
- ⑦ **자책**, 무가치감
- ⑧ **사고/주의집중력** 감퇴
- ⑨ **자살** 시도/자살 계획 또는 반복적 자살 사고

❖ 원인

1. 정신 질환 : 우울장애, 알코올 의존 등
2. 심리적 원인 : 충동성, 절망감 등
3. 사회적 원인 : 가족의 붕괴, 실직 등
4. 신체 질환 : 만성 통증 등



나만의 요약정리

Handwriting practice lines for summarizing notes.